2º CONGRESSO BRASILEIRO DE ENFERMAGEM DE FAMÍLIA E COMUNIDADE
2º CONGRESSO ALAGOANO DE MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE

Estratégia Saúde da Família: a potência brasileira que inspira o mundo
30 de abril a 2 de maio de 2026
MACEIÓ • ALAGOAS

Realização
ABEFACO
AAMFC

ACEITABILIDADE E DESCONTINUAÇÃO DO DIU INSERIDO POR PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM: REVISÃO DE ESCOPO

Iara Silveira Barbosa Machado[1], Walkelyne Lorrana de Sousa Portela Nogueira[1], Grazielly Ribeiro Tavares[1], Katiuscia Larsen de Abreu Aguiar[1], Luciene Rodrigues Barbosa[2]

[1]Universidade de Brasília - UnB
[2]Universidade Federal de Jataí - UFJ

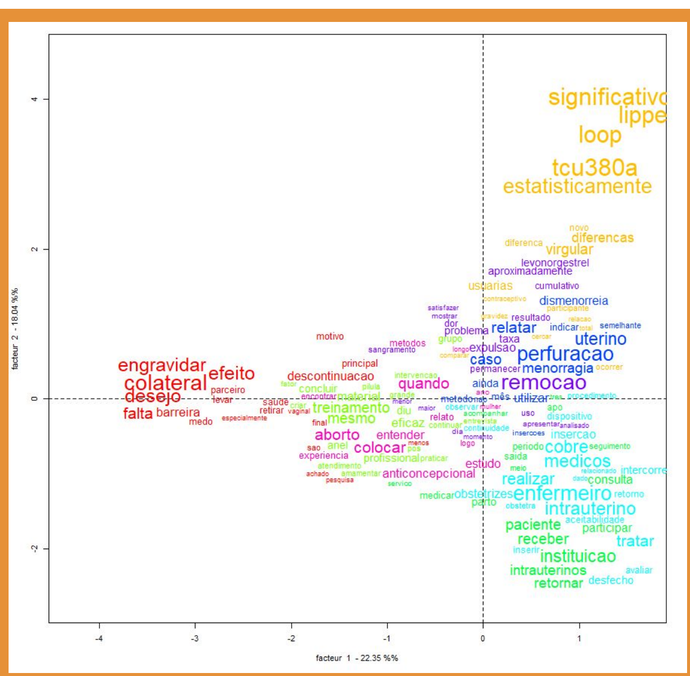

Figura 2 – Análise Fatorial de Correspondência (AFC), Brasília, Brasil, 2026.

PRINCIPAIS ACHADOS

- A análise fatorial revelou que a alta satisfação está vinculada à autonomia reprodutiva, à eficácia e à ausência de hormônios, sendo potencializada pelo aconselhamento pré-inserção centrado na usuária.
- Taxas de continuidade aos 12 meses variam entre 70% e 85% quando há seguimento longitudinal e follow-up qualificado pela enfermagem.
- O sangramento irregular é o fator determinante em 35% das remoções precoces, seguido por dor pélvica e expulsão espontânea (5-6%).
- Cerca de 80% das UBS brasileiras não oferecem a inserção do DIU, evidenciando uma lacuna assistencial e escassez de profissionais capacitados.
- A inserção por enfermeiros apresenta desempenho clínico e segurança equivalentes à técnica médica, sendo a categoria estratégica para a ampliação do acesso e redução da descontinuação prematura.

Introdução

O DIU de cobre é um método contraceptivo eficaz e reversível, porém subutilizado no Brasil (4,4%). A Resolução COFEN nº 690/2022 ampara o enfermeiro na sua inserção, mas cerca de 80% das UBS não oferecem esse serviço.

Objetivos

Mapear evidências sobre fatores clínicos, sociais e sistêmicos determinantes para a aceitabilidade e descontinuação do DIU.

Métodos

Revisão de escopo conforme JBI, com busca nas bases MEDLINE/PubMed, SciELO, LILACS e Scopus (nov/2025 - jan/2026), reportada pelo PRISMA-ScR. Foram incluídos 19 artigos de 14 países. A análise foi realizada por meio de síntese descritiva e de análise textual - software IRaMuTeQ®, empregando a Classificação Hierárquica Descendente e a Análise Fatorial de Correspondência.

Resultados

A análise gerou cinco classes lexicais. As classes de aceitabilidade indicaram satisfação entre 70 - 94%, associada ao aconselhamento pré-inserção e acompanhamento longitudinal pela enfermagem, bem como à escolha autônoma das mulheres baseadas no autocuidado. As classes de descontinuação evidenciaram sangramento aumentado (35%), expulsão (5 a 6%) e dor pélvica como principais barreiras, com taxas de descontinuação de 10 - 42%. Além disso, a descontinuação apresenta-se não somente como barreira clínica e sim sistêmica baseada em experiências vividas e a "retenção forçada" exemplificada pelos relatos de dificuldade em remover o dispositivo.

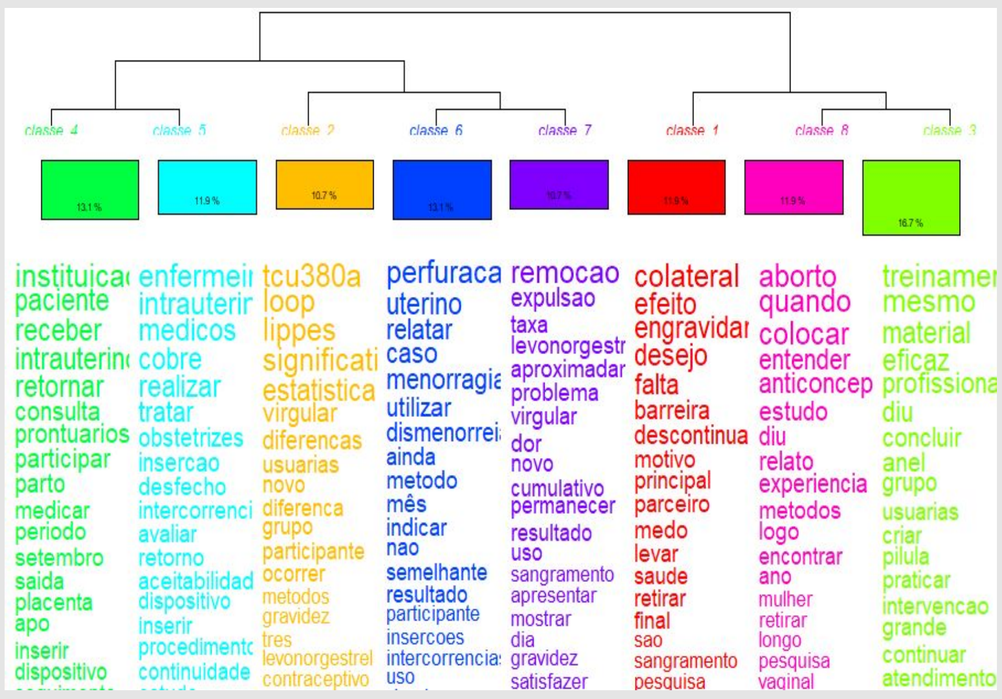

Figura 1 – Dendrograma da Classificação Hierárquica Descendente, Brasília, Brasil, 2026.

Considerações finais

A atuação do enfermeiro é estratégica para reduzir a descontinuação prematura, sendo necessários protocolos de seguimento e ampliação da capacidade técnica nas UBS.

INSTITUIÇÃO
IARA SILVEIRA BARBOSA MACHADO
UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA - UNB

E-mail: iarasilveira.enf@gmail.com
Contatos: (61)99617-6495

Universidade de Brasília